

- Mamuto

☒ ACOMPANHAMENTO		☐ CONSULTA	
NS			
PATRICIA MARA DUARTE MOREIRA			
IDADE: 47 anos	PESO: 100	ALTURA: 1,78	PROFISSÃO: Professora (já atuando)
SINTOMAS: Indisposição; Sono não reparador; Agitado; Dor no			
QUEIXAS: Depressão			
MEDICAMENTOS: Excitaloprom; Bupropiona; Pregabalin / dor corpo por QT			
MÉDICO: Dra. Priscila Otaviano			
MARCAPASSO: () S (X) N		COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N	
EXERCÍCIO FÍSICO: 0			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ:		ALMOÇO:	LANCHE: JANTAR:
HORA QUE DORME: 22h30'		HORA QUE ACORDA: 6h	
COCHILLO (X) SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO			
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: normal		BANHEIRO: N	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP:	MALLAMPATI: II	IAH: 40,8 e/h	SPO2: 87%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA (X) corneto nasais			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:			
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA			
(S) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
→ tumor fígado → última QT em maio/2023 - faz acompanhamento 3 mths. → fixação plombar bilat → fixo			
23/08 - Início do uso - Swift fx.			
30/08/24 P= 6,8 cmH ₂ O			
IAH= 0,4 e/h			
M. de uso: 5h46'			
Relato que no início da terapia, o escape quando muda p lateral.			
13/09/24 P= 5-7 cmH ₂ O / med: 6,8 cmH ₂ O			
IAH= 0,2 e/h			
m de uso: 5h6'			
Máscara adaptada por esta passando por período difícil do filho			
Natasha			
27/09/24 P= 5-7 cmH ₂ O / fixo em 7 cmH ₂ O			
IAH= 0,7 e/h			
m de uso: 5h38'			
Bem adaptada			
Natasha			
18/11			
24 P= 7 cmH ₂ O			
IAH= 0,5 e/h			
M. de uso: 5h30'			
duas claudis			

23/06 P. 7 cm 110
25 INH: $\frac{110}{25}$ está registrando.
ajuste a mãe.

Ass

COMPANHHEIRO USA MARCAPASSO: () SIM () NÃO

ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE ACORDA: DORME ACOMPANHADO: () SIM () NÃO

QUE DORME: () SIM () NÃO

ALCOOL: () SIM () NÃO

MACRODIA: () SIM () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

BANHEIRO: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: IAH: 40 cm

DE RESPIRAÇÃO ABDOMINAL: MALAMPATI: 1

ASSOCIADAS: (1) CARDIACA (2) AMIGDALECTOMIA

LOGIAS: (1) NASAL (2) ENDOCRINA

CAUSAS DA OBESIDADE: (1) RESPIRATÓRIA (2) OUTROS

POVERTILHAÇÃO DA OBESIDADE: (1) RESPIRATÓRIA (2) OUTROS

OMORBIIDADE: (1) NEUROLÓGICA (2) OUTROS

ORTOPÉDICA: (1) OUTROS

Nome: PATRICIA MARA DUARTE MOREIRA
Data de Nascimento: 26-4-1976
IMC: 34,60
Sexo: Feminino
Data do exame: 13-11-2023

Peso: 100 kg
Altura: 1,70 m
Médico: DRA. SISSI QUIRINO SILVA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 13-11-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 482,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 9,0 e 160,0 minutos. O tempo total de sono foi de 460,0 min, eficiência de 95,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,0%; estágio N2: 56,4%; estágio N3: 16,4%; sono REM: 25,2%. O índice de despertares foi de 23,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 40,8/hora, sendo 59 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 140 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 87%, permanecendo 0,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 97 bpm e NREM de 62 - 99 bpm.

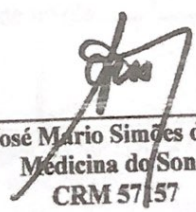
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (05), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N2 do sono NREM aumentada e porcentagem dos estágios N1 e N3 do sono NREM dentro da normalidade;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 40,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=87%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157



DR.
LUCIANO
ROTELLA

OTORRINOLARINGOLOGIA E SONO

Dr. Luciano Rotella

Título de Especialista em
Otorrinolaringologia.
ABORL - CCF

Especialista em Medicina
e Biologia do Sono - AMB

Graduação médica - UNIFESP
Escola Paulista de Medicina.

Solicito para tratamento de SAOS

CID: G47.3

() CPAP com pressão titulada de _____ cm H₂O

() BIPAP com pressão insp de _____ cm H₂O e exp

_____ cm H₂O

(✓) CPAP com pressão sugerida de 9 cm H₂O e

relatório após 20 dias de uso

(12) 3923-4000

Avenida 9 de Julho, 765,
1º Andar, Ed. Apollo Center,
São José dos Campos

Dr. Luciano Rotella
Otorrinolaringologista
CRM 113556

www.drlucianorotella.com